

ΝΥΓΜΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΥ

Γενικά: Όλοι οι σκορπιοί προκαλούν επώδυνους νυγμούς και έντονο τοπικό ερεθισμό, ενώ συστηματικές εκδηλώσεις προκαλούνται από συγκεκριμένα είδη, όπως τα *Centuroides* sp., *Tityus trinitatis* (οξεία παγκρεατίτιδα), *Bothriurus* sp., *Androctonus* sp. (κατεχολαμινική κρίση, μυοκαρδιακή βλάβη, αρρυθμίες), και *Hemiscorpius lepturus* (ιστική νέκρωση). Στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο επικρατεί ο ευρωπαϊκός τύπος σκορπιού (*Androctonus*) και ο ξανθόκερκος. Οι θάνατοι από σκορπιό είναι εξαιρετικά σπάνιοι και όποτε συμβαίνουν αφορούν συχνότερα στα παιδιά και σε άτομα τρίτης ηλικίας με συννοσηρότητα.

Κλινική εικόνα: Ο νυχθείς ασθενής πιθανώς να προσέλθει στο ιατρείο τρομοκρατημένος. Καταπραΰνουμε το άγχος του, τον διαβεβαιώνουμε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του από νυγμό σκορπιού και τον ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχουν θανατηφόροι σκορπιοί στην Ελλάδα.

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι **τοπικά** όπως ερύθημα, έντονη φλεγμονή, λεμφαδενίτιδα ή λεμφαγγειίτιδα, γάγγραινα ή **γενικευμένα** όπως σιελόρροια, αίσθημα βάρους και αιμωδία στη γλώσσα, αρχικώς βραδυκαρδία που μπορεί να μεταπέσει σε ταχυκαρδία ή σε άλλες αρρυθμίες, διάρροια, έμετοι, μυικές συσπάσεις, σπασμοί, διαταραχές όρασης, πριαπισμός, υπερτασική αιχμή, οξύ πνευμονικό οίδημα, καρδιογενής καταπληξία, τα οποία οφείλονται σε απελευθέρωση ενδογενών κατεχολαμινών και ακετυλοχολίνης, που προκαλείται από τη δράση του δηλητηρίου και εμφανίζονται περίπου μετά από 30-90 λεπτά από το νυγμό.

Το έντονο άλγος στο σημείο του νυγμού, οφείλεται στην 5-υδρόξυ-τρυπταμίνη (5-HT).

Ενημερώνουμε τον ασθενή ότι τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν από 2 έως 48 ώρες, αλλά πιθανώς το αίσθημα κακουχίας να παραμείνει ακόμη και για μία εβδομάδα.

Ιστορικό: Ελέγχουμε για την γενική κατάσταση του ασθενούς, για συννοσηρότητες, για πιθανή λήψη φαρμάκων για συστηματικά νοσήματα (*ΑΥ/ΣΝ, ΣΔ, λήψη κορτικοστεροειδών, ανοσοκαταστολή, κ.ά.*), καθώς και για ιστορικό αλλεργικών-αναφυλακτικών αντιδράσεων.

Θεραπευτική παρέμβαση

Σε περίπτωση νυγμού σκορπιού, τα τοπικά μέτρα όπως η προσπάθεια για την αφαίρεση του δηλητηρίου (π.χ. με ισχαιμη περίδεση και μικρή σχάση του δέρματος ύπερθεν του νυγμού), φαίνεται πως όχι μόνον δεν ωφελούν το θύμα, αλλά μάλλον το βλάπτουν. Έτσι, λοιπόν:

1. Ακινητοποιούμε το άκρο που υπέστη νυγμό, και εφαρμόζουμε ήπια ελαστικό επίδεσμο.
2. Εφαρμόζουμε τοπικά, κρύα επιθέματα (*παγοκύστες*), περιοδικά για 5-15 λεπτά, ώστε να μειώσουμε όσο το δυνατόν τη συστηματική απορρόφηση του δηλητηρίου, μέσω της προκαλούμενης εκ ψύξεως τοπικής αγγειοσύσπασης, ενώ επίσης μπορεί να επιχειρηθεί τοπική διήθηση της περιοχής του νυγμού με κάποιο αναισθητικό (π.χ. 3-5 ml Xylocaine).
3. Αν υπάρχει έντονο άλγος και μυικές συσπάσεις, τότε χορηγούμε ενδομυϊκώς **παισιόπινα** (1 amp. *Movatec, Xefo, Vialaxal* ή οποιοδήποτε ΜΣΑΦ, μαζί με 1 amp. *Apotel-plus*) και **μυοχαλαρωτικά** (1 amp. *Musco-Ril 4 mg* ή *Norflex 60 mg*). Τονίζεται ότι τα ναρκωτικά αναλγητικά αντενδείκνυνται, διότι ενισχύουν τη δράση του δηλητηρίου του σκορπιού.
4. Ανοσοποίηση, με αντιτετανικό ορό: [inj. Tetagam-P, 250 IU (ενδομυϊκώς-im)], άπαξ.
5. Στην περίπτωση εμφάνισης υπερτασικής αιχμής (*κατά το αδρενεργικό στάδιο*) χορηγούμε ενδοφλεβίως, 1 amp. Κλονιδίνη (*Catapres*) διαλυμένη σε 100-250 ml NaCl 0,9%, εντός 15-30 λεπτών, ελέγχοντας πάντοτε την ΑΠ και την καρδιακή λειτουργία του ασθενούς.

Σε περίπτωση επιδείνωσης, εμφάνισης μυικών σπασμών ή δεσμιδώσεων:

6. Χορηγούμε O₂ (4-6 lit/min), με μάσκα οξυγόνου ή μάσκα Venturi, ώστε SpO₂ > 90-92%.
7. Τοποθετούμε φλεβική γραμμή, με 1 amp. Stedon 10 mg σε 250 ml N/S, σε αργή έγχυση.
8. Χορηγούμε 1-2 amp. **Calcium Gluconate 10%**, εντός 250 ml διαλύματος D₅W ή N/S.
9. Νοσηλεύουμε τον ασθενή για λίγες ώρες στην MBN του ΚΥ ή εφόσον χρειαστεί τον διακομίζουμε στο νοσοκομείο, συνοδεία ιατρού, για περαιτέρω κλινική αντιμετώπιση.